

YIXUELUNLIXUE
YIXUELUNLIXUE

主编 / 郭乡村 黄妹 陈康

医学伦理学

医学
伦理学

吉林人民出版社

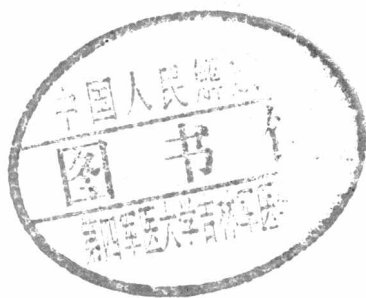


军医学院610 2 00738678

医学伦理学

主 编 郭乡村 黄 妹 陈 康

副主编 吴江生 张艳梅 张晓虎



吉林人民出版社

(吉)新登字 01 号

医学伦理学

主 编 郭乡村 黄 妹 陈 康
责任编辑 张 迅 封面设计 长 弓
责任校对 张艳梅 版式设计 张心平

出 版 者 吉林人民出版社
(长春市人民大街 124 号 邮编:130021)
发 行 者 吉林人民出版社
制 版 吉林人民出版社激光照排中心
印 刷 者 吉林大学科技印刷厂

开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 8.125
字 数 21.8 万字
版 次 2001 年 5 月第 1 版
印 次 2001 年 5 月第 1 次印刷
印 数 1—3000 册

标准书号 ISBN 7—206—03290—7/R·29
定 价 14.60 元

如图书有印装质量问题,请与承印工厂联系。

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 医学伦理学的研究对象和内容	(1)
第二节 医学伦理学的基本特征和作用	(5)
第三节 学习医学伦理学的意义和方法	(7)
第二章 医学道德的历史发展	(10)
第一节 中国医学道德的历史发展	(10)
第二节 外国医学道德的历史发展	(19)
第三节 中外医学道德思想的共同点	(28)
第三章 新时期的医学道德建设	(32)
第一节 医学模式转变的道德内涵	(32)
第二节 高科技时代的医疗与医师的职业道德	(36)
第三节 社会主义市场经济条件下的医德建设	(38)
第四章 医学伦理学的理论基础	(43)
第一节 生命论	(43)
第二节 人道论	(47)
第三节 美德论	(50)
第四节 公益论	(54)
第五章 医学道德的基本原则和规范	(57)
第一节 医学道德的基本原则	(57)
第二节 医学道德的基本规范	(64)

第六章 医学道德的基本范畴	(71)
第一节 权利与义务	(71)
第二节 情感与良心	(75)
第三节 审慎与保密	(77)
第四节 荣誉与幸福	(79)
第七章 医院人际关系道德	(82)
第一节 医院的特点和任务	(82)
第二节 医院人际关系概述	(84)
第三节 医疗人际关系的道德要求	(88)
第八章 医疗服务道德	(103)
第一节 医疗服务的态度与语言	(103)
第二节 临床诊断的道德要求	(107)
第三节 临床治疗的道德要求	(111)
第四节 临床其它科室的道德要求	(116)
第九章 护理道德	(128)
第一节 护理道德的含义、特点与作用	(128)
第二节 临床护理道德	(133)
第三节 护士的职业道德修养	(137)
第十章 预防医学道德	(142)
第一节 预防医学的一般道德原则	(142)
第二节 卫生防疫的道德要求	(148)
第三节 环境道德与环境保护	(151)
第十一章 医学研究与人体实验道德	(156)
第一节 医学研究的道德本质	(156)

第二节	医学研究的道德要求·····	(157)
第三节	人体实验道德·····	(163)
第四节	尸体解剖道德·····	(167)
第十二章	临床医学伦理难题·····	(171)
第一节	人工流产·····	(171)
第二节	生殖技术·····	(174)
第三节	器官移植·····	(178)
第四节	基因诊断与基因治疗·····	(181)
第五节	安乐死与临终关怀·····	(185)
第六节	医疗卫生资源的分配·····	(191)
第十三章	医学道德活动·····	(196)
第一节	医学道德评价·····	(196)
第二节	医学道德教育·····	(204)
第三节	医学道德修养·····	(209)
附录：	国内外医德文献资料·····	(216)
	主要参考文献·····	(249)
后记	·····	(250)

第一章 绪 论

伦理学是关于道德的科学,亦称道德哲学,是一门古老的学问。在西方,伦理学发端于公元前四世纪,由古希腊的哲学家亚里士多德创立,特指关于道德品行的学问。在中国,伦理学源远流长。中国古代的“伦理”一词是对有关人伦事理、思想规范和行为准则等道德现象的概括,儒家的《论语》、《孟子》等书是具有中国特色的伦理学著作。

医学伦理学属于应用伦理学,是医学和伦理学相交叉的学科。医学伦理学是一般伦理学原理在医疗实践中的具体运用,是运用伦理学的理论来解决医疗实践和医学科学发展中人们相互之间、医学团体与社会之间关系的一门学问。可见,医学伦理学是研究医学实践中的道德问题的科学,是关于医学道德的学说和理论体系。它既是规范伦理学的一个分支,又是医学的组成部分,医学中蕴含着伦理因素,伦理学贯穿于医学实践的全部过程。医学伦理学运用伦理学的理论研究医学实践中的伦理问题,成为医务工作者知识和素质结构的重要组成部分,并长期在医学实践中起导向作用。

第一节 医学伦理学的研究对象和内容

一、医学伦理学的研究对象

医学伦理学是以医学道德为研究客体,研究医疗卫生保健领域中的所有道德现象,研究以医患关系为核心的医疗、预防、科研、保健以及生命科学等诸多方面的道德问题。现代医学伦理学还涉及到优生优死、人与环境的关系、行为因素与健康的关系、卫生政策与卫生资源,以及与人身心健康的广泛的社会问题。医学伦理学研究在处理上述关系时应遵循的伦理原则和行为规范,研究如何将这些原则和规范转变为医务人员自觉的行为和信念。

医学伦理学对各种医德现象和医德关系进行了全面、历史、具体的考察、分析,揭示其内在矛盾、基本特征和客观规律性。

医德现象包括医德意识现象、医德规范现象和医德活动现象。医德意识现象,即医学道德的思想观点和理论体系,属于医德的主观方面,包括医德观念、情感、意志、信念等。医德规范现象,即在医学实践中评价和调整医生行为的准则,是社会对医务人员处理医患关系及其行为的基本要求的概括。医德活动现象,即医生根据一定的观念,遵循一定的医德准则,在医学实践中进行医德评价、医德教育和医德修养等,是主观见之于客观的方面。总之,医学道德既以观念、理论等意识形式存在于医学实践中,又以原则、规范形式构成医学道德的规范体系,指导着医务人员的实践。医学伦理学从观念形态上研究医德理论,又从职业特征上研究医德规范,还紧密结合医学活动研究医德实践。

医德关系是一种职业道德关系。医学伦理学所研究的医德关系,主要是揭示医务人员的个人利益与他人利益、与社会整体利益的矛盾,研究反映这种矛盾规律的医德理论,制定解决这种矛盾的原则和规范,以及医德评价的标准和方式,讨论进行医德教育、医德修养的途径和方法。医德,关系到人的生命安危,涉及到社会的各个方面,对人类的发展影响极大,因而受到全社会的关注。

医德关系,主要包括以下几个方面:

(一)医患关系

医患关系即医务人员与病人之间的关系,是医学实践中的基本关系,是医学伦理学研究医德关系的核心内容。在医患关系中,医患之间是服务与被服务的关系,医者处于主导地位。医德调节的突出特点是以医者作出必要的节制和牺牲,来调节医学实践中的个人利益与他人利益、社会整体利益的矛盾。处理医患关系的基本原则,是医者把患者的利益放在第一位,全心全意为患者的身心健康服务,这就是医学伦理学的义务论。随着现代医学的发展和伦理观念的更新,围绕着医患关系,出现了一系列理论和实践问题,传统意义上的义务论受到了挑战。在这样的情况下,公益论、价值论被引入到医学伦理

学领域,为更合理地调节医患关系提供了全新的原则。

(二)医际关系

医际关系即医务人员之间的关系,包括医生之间、医护之间、护士之间、医生与医技人员之间、医护技与医院管理人员之间的关系。处理这些关系的伦理原则是平等互助、分工协作、公平竞争。在现实生活中,比较突出的矛盾是:如何确定各级医生间的职责以及协调医护、技、管之间的关系;如何对待同行中的差错事故;医际之间应建立怎样的竞争规则等等。

(三)医社关系

医社关系即医务人员、医疗卫生部门与整个社会的关系,这是医学活动和医学道德评价日益社会化的产物。医务人员在履行职责时,不仅要对个人患者负责,而且要对整个社会负责。这里主要有两个方面的问题:

1. 医务人员在为患者作出诊断时,必须既处理好患者个人的正当权利,又充分考虑社会整体利益和大众健康公益。

2. 在医疗资源配置和调整卫生事业格局时,投入的重点是高层次服务、高精尖研究,还是保证大多数人的健康维护、常规性的医疗设备等等。归纳起来是医学发展与社会各层次健康服务需求如何适应的问题,是社会整体健康效益与社会群体间的公平。

(四)医学科研与医学科学发展的道德关系

医学研究道德是医学科学研究中的重要问题,是医学科研的灵魂。医务人员在从事医学研究时,必须遵循相关的道德准则和规范,包括严谨治学、实事求是的科学态度;配合协作,尊重同道,合理分配荣誉的科研道德品格;坚持医学人道主义精神,坚持受试者健康利益与医学发展的整体利益的内在统一。

(五)医学和社会发展带来的新伦理问题

医学中存在着固有的进退维谷、两难选择的问题,如医务人员如何选择讲真话与守密原则问题;医疗实践中一些不可避免的损伤原则问题;审慎与担风险的价值选择等,这些都有异于一般的道德现象,经常令医务人员左右为难。还有如生育控制、器官移植、行为控

制、潜生命科学研究、死亡的对待等一些生命伦理学问题,诸多新问题已经提到医务工作者的面前,对此医学伦理学以及生命伦理学将逐步进行研究、论证,提出有指导意义的原则和规范。

二、医学伦理学的内容

医学伦理学有着完整的学科体系,内容十分丰富,既是对传统医德思想的继承,又是对现代医学伦理观念的概括。其内容大致由三部分组成,即医德理论、医德规范和医德实践。

医德理论是医学伦理学的精髓,主要论述医学道德的本质、特征、社会作用、历史渊源、文化属性、基本范畴和发展规律。在我国,医德理论必须以马克思主义理论为指导,以人们的社会物质关系作为医学道德赖以产生和发展的前提。医学道德作为一种社会意识形态,是在人类同疾病作斗争的实践中产生和发展起来的。它既受社会经济关系表现出来的利益关系的制约,又受医疗实践和医学技术发展的制约。不同利益关系,不同的医学发展水平,会产生不同的医德观念和医德规范;同时,一定的医德观念和规范,一旦形成,就具有相对独立性和稳定性,并具有比一般社会道德更加稳定的自身发展特点,对社会的政治、经济、思想、文化等方面有重要影响。

医德规范是体现医学伦理学特征的基干。医学伦理学是一门规范科学,它的规范体系在整个学科中占有重要地位。它告诫医务人员,什么样的行为是善的,什么样的行为会导致恶果,应该怎样,不该怎样,在医学活动中应自觉选择符合医德规范的行为,扬善抑恶。

医德实践是医学伦理学的基础。医学伦理学来源于医学实践,是对医学实践的概括和总结,又不断作用于医学实践、指导医学实践。学习医学伦理学,归根结底是使医学实践符合道德要求,使医学实践在道德的轨道上进行。医德评价、医德教育、医德修养是医德实践的具体内容。

当代医学伦理学的研究范围已扩展至生命科学和整个医疗保健领域,甚至涉及到与人类生命密切相关的生态伦理和同人类健康有关的各种社会问题。当代医学伦理学在生命质量论和生命价值论的基础上形成了一门崭新的学科——生命伦理学。研究人类自身发展

和完善中面临的现实问题的生命伦理学是医学伦理学发展的新阶段,已经引起世界各国的重视。本书将结合临床实践中的医学伦理难题介绍生命伦理学的有关理论和动态。

医学伦理学的道德理论、道德规范和道德实践,既相对独立,又相互贯通,构成了医学伦理学的学科体系。

第二节 医学伦理学的基本特征和作用

一、医学伦理学的基本特征

医学伦理学是医学和伦理学交叉的学科。医学伦理学具有以下基本特征。

(一)实践性特征

医学伦理学是一门与医学实践密切相关的科学。医学伦理学的理论、规范来源于实践,是对医学实践中的道德关系、道德意识、道德行为的概括和讨论,是在长期的医学活动中形成、发展的,而来源于医学实践的道德原则、道德规范又对医学活动起着重大指导作用。医学实践既是医学伦理学的基础动力,又是医学伦理学的目的和检验医学伦理学理论正确性的标准。卫生事业是为人的生老病死服务的特殊行业,医务工作者的天职就是为人民的身心健康服务。医务人员树立良好的服务意识、培养优秀的思想品质和工作作风的目的在于提高业务水平。医学伦理学的实践性特征决定了它在人类社会生活中,具有不可替代的作用。

(二)继承性特征

医学伦理学同人类其他文化现象的发展一样,具有历史连续性。医学道德是贯穿医学发展的一条主线,弘扬医学道德传统是医学进步的基本条件和重要标志。任何时代的医德都是以往医德的积淀。因此,“救死扶伤”、“为医者仁”,“医不贪财,不猎色,不伤害病人”,“医乃仁术”、“病人健康高于一切”、“医生要忠于职守”、“同业相助”、“尊重同道”、“严守医密”、“一视同仁”等等,成为医疗活动中历代相传、不断发扬光大的基本原则。

继承和发展历史上各个时代关于医德理论的精华,继承人类伦理思想史上一切有价值的优秀成果,根据医学科学发展的时代特点以及医疗实践需要,完善和发展医学的道德传统是当代医务工作者的任务。

(三)时代性特征

医学道德并不是一成不变的,而是伴随着社会进步而不断发展的。医学的发展,不仅表现为诊治疾病手段的进步,而且表现为医学道德的进步。任何时代的医学道德都具有所处时代的特征,都是为解决该时代的具体问题而存在的。在古代,为妇女堕胎被认为是违反道德的;在当代,为维护社会和妇女自身的利益开展的计划生育手术则被普遍认为是道德之举。医德原则、医德规范、医德评价、医德教育都是时代的产物,都不能脱离时代。反映社会对医学的需求、为医学的发展导向、为符合道德的医学行为辩护是医学伦理学的任务。

二、医学道德的社会作用

道德属上层建筑和意识形态范畴,是由社会经济基础所决定的。同时,又是一种能动的、积极的因素,对社会物质生活条件有巨大的反作用,对社会精神生活方面产生重大影响。医学道德与一般社会道德一样具有重大的社会作用。不同的医德观念和医德风尚对医际关系、医疗质量、医学发展和整个社会风尚都有重要影响。

医学道德的社会作用,具体表现在以下几个方面。

(一)对医院人际关系的调节作用

现代医学事业是一项系统工程。在医疗活动中有着纷繁复杂的医际关系,如何调节这些关系是每位医务工作者必须面对和解决的问题。医学伦理学强调以患者为中心,尊重病人的权利,遵循社会主义医德原则和规范,协调医院各系统间各类人员的关系和医患之间的关系,维护患者利益和社会利益的统一,由此实现医学的目的。为此,就需要加强医德教育,发挥医德对医院人际关系的调节作用。

(二)对医疗质量的保证作用

医疗质量是医学的生命,提高医疗质量是医学系统工程的根本目标。它的基本要素是高尚的医德、精湛的医术和良好的设备。三者

相辅相成,以医德为灵魂。医疗实践的无数事实证明,医德的优劣与医疗质量直接相关。那些医德高尚的医生,往往又是医术精湛的医生,他们全身心地为病人的身心健康服务,能使医疗目的得以圆满实现。反之对工作不负责任,对病人不关心、不热情,医疗技术不精,粗枝大叶,就极易出现医疗差错和责任事故,损害人民的健康,甚至危及生命。总之,医务人员和医疗卫生单位医德的总体水平,会直接影响医疗质量。普及医学伦理学知识,强化医德意识,提高医务人员的职业道德水平,是保证和不断提高医疗质量的重要方法

(三)对医学科学的促进作用

医学科学与医学道德是共同发展的,存在着内在的必然联系。医学的对象是人,而人又是社会关系的总和,总是处在一定的伦理关系之中。从医学与医学道德的发展历史,我们可以发现医学发展与医德进步的密切关系。医学每前进一步,就要求医德与之相适应,新的医德观一经产生,就会对医学的发展有促进作用。它规定着医学科学研究的方向,并通过医学科研人员的大无畏的献身精神去研究医学科学的新情况、开辟新领域、掌握新规律。如法国近代微生物学家、微生物学的奠基人巴斯德,就是在这种献身精神的推动下发现“狂犬疫苗”的。

(四)对社会文明的推动作用

医院是社会文明的窗口,医德医风是社会文明的重要组成部分。医学涉及到千家万户,医疗卫生行业与社会广泛联系,在医学模式发生转变的今天,使这种联系更为密切。因此,医学道德建设的社会作用不仅局限于医院、医务界,而是整个社会精神文明建设的重要组成部分。

第三节 学习医学伦理学的意义和方法

一、学习医学伦理学的意义

(一)学习医学伦理学有利于培养高素质医学人才

医学伦理学是医学院校培养高级医学人才的必修课,是提高学

生素质、完善知识结构不可缺少的重要内容。21 世纪的医学人才,应该首先具备良好的思想道德素质,其次是渊博的科学文化知识和精良的医疗技术。纵观中外医学史,著名的医生无一不是医德高尚的光辉典范。医学生学习医学伦理学,掌握社会主义的医德原则、规范,自觉进行医德修养,不断提高职业道德素质,才能健康成长。当代医学生是跨世纪的一代,建设有中国特色的社会主义卫生事业的历史重任必然由他们承担,教育引导他们树立正确的医学道德价值观,不仅关系到他们个人的成长,而且关系到中国卫生事业的发展。可见,学习医学伦理学对完善医学人才的基本素质具有重要的意义。

(二)学习医学伦理学有利于推动医学科学的发展

医学伦理学与医学科学的发展密切相关。从医学发展史看,医学伦理价值观念直接影响着医学科学的发展。例如,欧洲在中世纪禁止尸体解剖,直接影响到临床医学的发展。现代医学科学的飞速发展,也影响和改变着人们的医学伦理价值观,尤其是生物工程技术在临床医学中的广泛应用,提出了一系列伦理问题,医学伦理学在不断吸取医学科学技术发展的新成果,建立和形成新的医学伦理价值观。掌握和运用这些新的医学伦理价值观,就能够研究和解决新问题,对于生物医学进展给医学带来的前所未遇的伦理难题,就能够科学论证和回答为什么和怎么办,保证医学自身价值的顺利实现,促进医学事业的健康发展。

二、学习医学伦理学的方法

(一)联系实际,掌握理论

学习医学伦理学,首先要由不知到知,再由知之不多到知之较多、甚多。因此,掌握领会基本概念、观点、原则是必要的。但是医学伦理学是一门规范性和实践性很强的学科,对医学伦理学的学习,不能停留在条条的学习、记忆上。只有密切联系医学实际才能掌握医学伦理学的理论和原则。

(二)知行统一,自觉修养

学习医学伦理学的最终目的是提高从医者的医德水平,所以知行统一是学习医学伦理学的根本方法,要做到知、情、信、意、行的统

一。知行统一在于自我磨练、自我修养,要在实践中培养医德情感,磨练医德意志和信念,修养医德品质,身体力行,躬行践履。

(郭乡村 黄 妹)

复习思考题

1. 医学伦理学是一门怎样的学问?
2. 医学发展与医德的关系如何?
3. 医学伦理学研究的对象和内容是什么?

第二章 医学道德的历史发展

崇尚道德是医学的优良传统。探讨中外传统医德理论与实践,掌握中外传统医德的基本精神,汲取和弘扬人类文明中的医学道德精华,不仅有助于学习和研究医学伦理学,也有助于提高医师的职业道德素质。

第一节 中国医学道德的历史发展

中国医学是世界医学的一朵奇葩,在其漫长的历史发展过程中形成了丰富的医德思想,涌现出许多医术精湛、医德高尚的医学家,他们在医疗活动中表现出的崇高境界对当代医务工作者具有重要的借鉴意义。

一、中国传统医德的历史演变

中国传统医德源远流长,其产生和发展经历了一个漫长的历史过程。人类医药活动是伴随着道德思想的产生而产生的。在人类生产实践过程中,远古时期的人类为了能得以生存和发展必须靠群体的力量,对群体中其它成员的关爱成为早期医药活动产生的巨大动力。《淮南子·鸿烈解修务训》中记载:“古者民茹草饮水,采树木之实,食羸蚘之肉,时多疾病毒伤之害,于是神农乃教民播种五谷,相土地,宣燥湿,肥晓高下,尝百草之滋味,水泉之甘苦,令民知所避就,当是之时,一日而遇七十毒。”《史记·补三皇本记》记载:“神农尝百草始有医药”,而传说中伏羲氏制九针,燧人氏钻燧取火,也都是远古时期为了氏族、部落成员得以生存而在实践中产生的早期保健活动。到殷周时期,这种对他人的关爱从出土的甲骨文和当时的医书中清晰可见。

春秋时期,儒家思想的“仁”对医德思想有重要的影响,医学人道主义思想开始萌芽。儒医称医学为“仁术”。“医乃仁术”“仁者爱人”。这一思想要求医家治病要以“无伤”为原则。孟子说“无伤也,是乃仁

术”。在用药上更要慎重，“若药不瞑眩，厥疾不瘳”。“仁术”要求医生要有热爱医药事业的恒心，《论语·子路》指出“人而无恒，不可作巫医”。在道德修养上，儒家要求“慎独”，严于律己。此外，儒家注重人口质与量的统一，重视优生优育。孔子提出“女子有五不娶”“礼不同姓”，认为“同姓结婚，其生不蕃”。儒家主张男子“三十而有室，始理男事”，女子“十有五年而笄，二十而嫁，有故，二十三年而嫁”（《礼记·内则》）。在环境道德方面，认为“赞天地之化育，则可以与天地参矣”（《中庸》），主张保持生态平衡。

战国时期，中国进入了封建社会。生产实践，特别是医学实践有了更大的发展，形成了朴素的医学人道主义思想。成书于此时的《黄帝内经》是目前我国最早阐述医德的医书，对医德的论述极为深刻。它强调“天覆地载，万物悉备，莫贵于人”。人命之贵，一失不可复得。作为决人生死的医生，在诊治中必须认真负责，一丝不苟，绝不可粗枝大叶或敷衍塞责。《素问》中指出医道是一门“至道在微，变化无穷”的“精光之道，大圣之业”，不是随便什么人都可以掌握的，对医学生或学徒的挑选应极为慎重，做到“非其人勿教，得其人乃传”。认为“得其人不教，是谓失道，传非其人，慢泄天宝”（《气交变大论》）都是一种不严肃和不负责任的态度。

秦汉三国时期，由于连年战乱，瘟疫流行，一方面给人民带来了死亡、灾难，另一方面又促进了医学的发展，促使医学人道主义觉醒。淳于意、张仲景、华佗等大医学家以自己的言行大力倡导医德。张仲景在《伤寒杂病论·自序》中明确提出“精究方术”是为了“上以疗君亲之疾，下以救贫贱之厄，中以保身长全，以养其生”，明确指出了医学的目的是治病救人。在诊治过程中，严肃认真的态度日益受到重视，张仲景严厉批评那种“按寸不及尺，握手不及足”“相对斯须，便处汤药”的草率行为。这一时期也很重视对疾病的预防，《淮南子·说山训》说：“良医者，常治无病之病，故无病，圣人者，常治无患之患，故无患也。”张仲景提倡饮食有节起居有常，劳逸适当的保健方法，劝导人们不吃瘟兽肉、臭鱼、馊面等，提倡气功、按摩。华佗发明了一套体操“五禽之戏”用于锻炼身体。